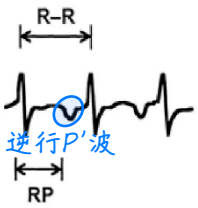
（二）交界早

1.尽管多见于器质性心脏病者、但多不治疗

P'R间期<0.12s:
预激(Kent束)
交界早(先有逆行P'波再有QRS波)





2.心电图（双向奔赴）

①可见**逆行 P'波**（**II、III、aVF 导联倒置**下壁）

②可见**提早出现 QRS 波**、形态多正常（除非发生室内差异性传导）

③逆行 P'波可在 QRS 波之前（P'R 间期＜0.12s）、可在 QRS 波之后（RP'间期＜0.2s）、可与 QRS 波重叠

④交界早后常出现**完全**性代偿间隙（早搏在内的 PP 间距=正常 PP 间距的 2 倍）

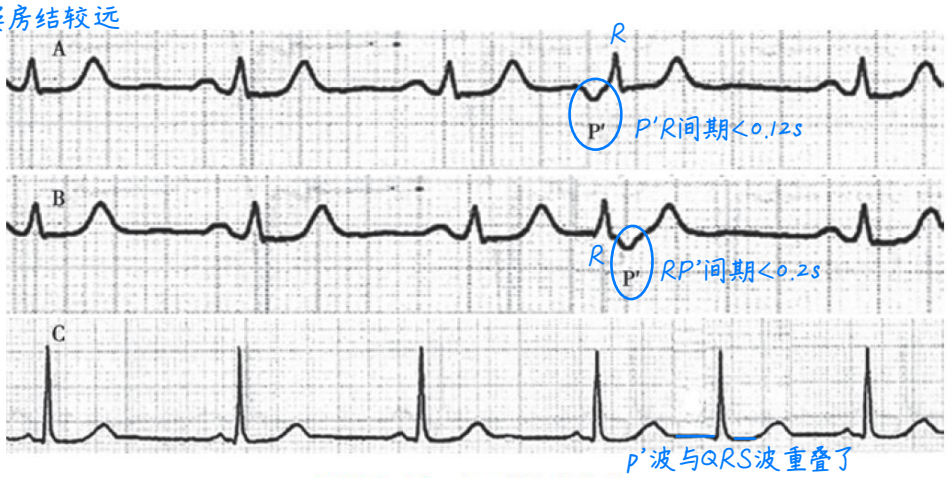


图 5-1-59　交界性期前收缩

A. 逆行 P′ 波出现在 QRS 波群前面；B. 逆行 P′ 波出现在 QRS 波群后面；C. 逆行 P′ 波与 QRS 波群相重叠。

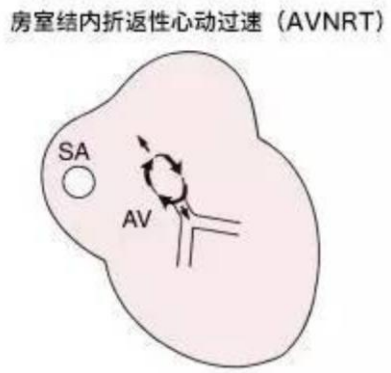
室上速
- 与折返无关:非阵发性房室交界性心动过速(强心苷中毒)
- 与折返有关:阵发性室上性心动过速(室上速)
  - ①突发突止 ②心律绝对规则 → AVNRT
  - AVRT

(强心苷中毒:①抑制钠泵→膜电位↓→与阈电位距离近→增加异位起搏点的自律性②促进细胞内钙增多→加速4期自动去极化的速度→增强异位起搏点的自律性)

（三）阵发性室上性心动过速

1.最主要发生机制是房室结折返——**房室结折返性心动过速**（atrioventricular nodal reentrant tachycardia,AVNRT），多由房早触发，**心电生理检查最佳——慢快型房室结折返**（房室结慢径前传、快径逆传）

（要么房早要么交界早触发，越靠上面异位起搏点自律性越高、越容易触发）



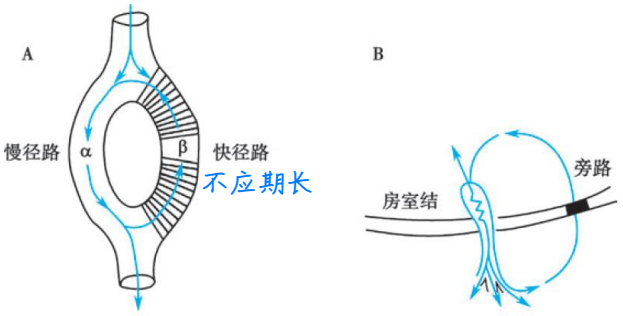


图 5-1-65　房室结折返性心动过速和房室折返性心动过速发生机制示意图

A. 房室结折返性心动过速；B. 房室折返性心动过速。

